

บทบาทพยาบาลจิตเวชในการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกัน ภาวะซึมเศร้าสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง

The role of psychiatric nurse in mental health promotion and depression prevention for older adults with chronic illness

ศิริลักษณ์ ปัญญา

Siriluck Panya

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

Faculty of Nursing, Ratchathani University, Udonthani Campus.

บทคัดย่อ

ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะภาวะซึมเศร้าซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความสามารถในการดูแลตนเอง พยาบาลจิตเวชมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง โดยใช้แนวคิดการดูแลแบบองค์รวมร่วมกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ และแนวคิดสุขภาพจิตเชิงบวกของจาฮอดา พยาบาลจิตเวชมีบทบาทสำคัญทั้งในด้านการประเมินภาวะสุขภาพจิต การให้คำปรึกษาและบำบัดทางจิตใจ การส่งเสริมสุขภาพจิต การสนับสนุนการปรับตัว การทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และการพิทักษ์สิทธิโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต เช่น การให้คำปรึกษาผ่านระบบดิจิทัล แอปพลิเคชันสุขภาพจิต และการติดตามต่อเนื่องผ่านระบบบริการสุขภาพทางไกล อันเป็นแนวโน้มบทบาทสำคัญในยุคปัจจุบันซึ่งช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวต่อโรคเรื้อรัง ลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้า และมีสุขภาพจิตที่ดีอย่างยั่งยืน อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมไทย

คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ, โรคเรื้อรัง, สุขภาพจิต, ภาวะซึมเศร้า, พยาบาลจิตเวช

Abstract

Older adults with chronic illnesses are at high risk of developing mental health problems, particularly depression, which negatively affects their quality of life and self-care capacity. Psychiatric nurses play a crucial role in promoting mental health and preventing depression among older adults with chronic conditions by applying a holistic care approach informed by relevant theories, including Maslow's Hierarchy of Needs and Jahoda's Positive Mental Health. Their roles encompass mental health assessment, counseling

Corresponding author E-mail: [sririluck@rtu.ac.th](mailto:siriluck@rtu.ac.th)

วันที่รับบทความ: 2 ธันวาคม 2567 วันที่แก้ไขบทความ: 26 กรกฎาคม 2568 วันที่ตอบรับบทความ: 18 กันยายน 2568

ความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว พร้อมสร้างเครือข่ายสนับสนุนทางสังคมและเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า (Cuijpers et al., 2020) ดังนั้น พยาบาลจิตเวชจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง ผลกระทบของภาวะซึมเศร้า แนวทางการดูแลสุขภาพจิตแบบองค์รวม บทบาทของพยาบาลจิตเวชในการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันภาวะซึมเศร้า เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังได้

ภาวะสุขภาพจิตในผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง

ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคข้อเสื่อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจ โดยเฉพาะสุขภาพจิตที่มีแนวโน้มแย่ลงอย่างชัดเจน ปัญหาที่พบมีตั้งแต่ความเครียด ความวิตกกังวล ไปจนถึงภาวะซึมเศร้า (Murayama et al., 2020) โดยผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานมักเผชิญความเครียดจากการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล ขณะที่ผู้ที่มีประวัติโรคหลอดเลือดสมอง หากขาดการสนับสนุนทางสังคม จะมีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังยังต้องเผชิญกับความเครียดเรื้อรังจากการดูแลตนเอง ข้อจำกัดด้านร่างกาย และการพึ่งพาผู้อื่นซึ่งต่างส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจจะมีความชุกของภาวะซึมเศร้าสูงถึงร้อยละ 40 (Liguori et al., 2018) ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ความเจ็บปวดเรื้อรัง ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันที่ลดลง การขาดการสนับสนุนทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงในสถานะครอบครัว โดยเฉพาะในกลุ่มที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวหรือประสบปัญหาเศรษฐกิจจะพบภาวะซึมเศร้าได้สูงกว่า (Murayama

et al., 2020; Kim et al., 2021)

ผลกระทบของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง

การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังไม่เพียงกระทบต่อสุขภาพกายแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพจิต โดยเฉพาะอาการซึมเศร้า (depression) ที่สัมพันธ์กับความทุกข์ทางจิตใจและความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่สูงขึ้น ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังมีแนวโน้มเกิดภาวะซึมเศร้ามากกว่าผู้ที่ไม่มียโรค ซึ่งสัมพันธ์กับทั้งปัจจัยทางชีวภาพ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทและการอักเสบเรื้อรังที่กระทบต่อสมอง รวมถึงปัจจัยทางจิตสังคม ได้แก่ ความโดดเดี่ยว ความรู้สึกไร้คุณค่า การขาดการสนับสนุนจากครอบครัว และความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ (Lin et al., 2024) นอกจากนี้ ผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการทำกิจวัตรประจำวันมักรู้สึกสิ้นหวังและวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคต ทำให้เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น โดยมักแสดงอาการผ่านอาการทางกาย เช่น ปวดเมื่อยเรื้อรัง นอนไม่หลับ หรือเบื่ออาหาร มากกว่าการแสดงออกทางอารมณ์ (Devita et al., 2022) ภาวะซึมเศร่ายังเป็นอุปสรรคต่อการดูแลสุขภาพตนเอง เช่น การรับประทานยา การออกกำลังกาย และการพบแพทย์ตามนัด ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและคุณภาพชีวิตลดลง (López et al., 2024) ทำให้ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังและภาวะซึมเศร้ามียอัตราการเข้ารับการรักษารักษาในโรงพยาบาลสูงกว่ากลุ่มอื่น และเพิ่มภาระต่อระบบบริการสุขภาพ (Liguori et al., 2018) นอกจากนี้ยังพบว่า ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่สูงขึ้น (Kim et al., 2021)

แนวทางการดูแลสุขภาพจิตแบบองค์รวม

การดูแลสุขภาพจิตแบบองค์รวม (holistic mental health care) มุ่งสร้างสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ไม่เพียงเน้นการรักษาอาการทางกาย

แต่ครอบคลุมการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการจำเป็นของ Maslow (1943) เพื่อสนองความต้องการพื้นฐานจนถึงการบรรลุศักยภาพสูงสุด และแนวคิดสุขภาพจิตเชิงบวกของ Jahoda (1958) ที่เน้นการปรับตัว การควบคุมสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งเป็นรากฐานของสุขภาพจิตที่มั่นคง แนวทางการดูแลประกอบด้วย

1. ด้านร่างกาย: เน้นการตอบสนองความต้องการพื้นฐานตามแนวคิดของมาสโลว์ เช่น การออกกำลังกาย ช่วยลดภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล ผ่านการกระตุ้นการหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน (endorphins) การรับประทานอาหารที่มีคุณค่าต่อสมอง และการนอนหลับที่มีคุณภาพซึ่งมีส่วนช่วยลดความเครียดและภาวะซึมเศร้าได้ (Sieniawska et al., 2024)

2. ด้านจิตใจ: การฝึกสติ (mindfulness) การทำจิตบำบัดแบบสั้น (brief therapy) และการสนับสนุนด้านจิตวิทยา ช่วยเพิ่มทักษะการเผชิญปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางอารมณ์ (Shih et al., 2021) ซึ่งจะสอดคล้องกับองค์ประกอบสุขภาพจิตเชิงบวกของจาฮ็อดา

3. ด้านสังคม: การสนับสนุนจากครอบครัว การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม หรือชุมชนสูงวัยมีส่วนช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวและเสริมสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Hoang et al., 2022)

4. ด้านจิตวิญญาณ: การค้นหาความหมายในชีวิต การทำสมาธิ หรือการประกอบศาสนกิจ ช่วยเพิ่มความสงบภายในและเสริมพลังใจ (Koenig, 2012) ซึ่งสะท้อนแนวคิดความต้องการในการบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง (self-actualization) ตามทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการจำเป็นของมาสโลว์ ที่เน้นการเติมเต็มศักยภาพและความสุขภายในจิตใจ

การบูรณาการทั้ง 4 ด้านและเชื่อมโยงกับทฤษฎีจะช่วยให้ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังมีสุขภาพจิตที่มั่นคง

สามารถปรับตัวต่อปัจจัยกดดันทางร่างกายและจิตใจ ลดความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

บทบาทของพยาบาลจิตเวชในการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง

พยาบาลจิตเวชมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ แม้ต้องเผชิญกับข้อจำกัดทางร่างกายและจิตใจ ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นบทบาทที่สำคัญต่อการดูแลซึ่งจะมุ่งเน้น การประเมินภาวะสุขภาพจิต การให้คำปรึกษาและนำบำบัดทางจิตใจ การส่งเสริมสุขภาพจิต การสนับสนุนการปรับตัว การทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และการพิทักษ์สิทธิ โดยบทบาทสำคัญของพยาบาลจิตเวช 6 ด้านหลัก มีรายละเอียด ดังนี้

1. การประเมินภาวะสุขภาพจิต พยาบาลจิตเวชทำการคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงทางจิตใจอย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน เช่น Geriatric Depression Scale (GDS), Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) และ UCLA Loneliness Scale ควบคู่กับการสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง เพื่อให้เข้าใจบริบททางสังคมและอารมณ์ของผู้สูงอายุ (O'Connor et al., 2023)

2. การให้คำปรึกษาและการนำบำบัดทางจิตใจ โดยใช้เทคนิคที่เน้นความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจ เช่น Cognitive Behavioral Therapy (CBT) และการนำบำบัดด้วยสติ (Mindfulness-Based Therapy) ซึ่งสามารถลดภาวะซึมเศร้าและเพิ่มความสามารถในการปรับตัวของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Xiang et al., 2024; Ye et al., 2024)

3. การส่งเสริมสุขภาพจิต ผ่านการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัวเกี่ยวกับการจัดการโรคเรื้อรังและอารมณ์ โดยใช้สื่อดิจิทัล แอปพลิเคชันติดตามอารมณ์ และการฝึกผ่อนคลาย เพื่อลดความเครียดและยกระดับคุณภาพ

ซีวิต (Serrano-Ripoll et al., 2022; Xiang et al., 2024; Wu et al., 2022) ในยุคดิจิทัล พยาบาลจิตเวชควรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อใช้เทคโนโลยีสุขภาพจิต เช่น โปรแกรมฝึกสมาธิออนไลน์ แอปพลิเคชันติดตามอารมณ์ หรืออุปกรณ์สวมใส่ที่ช่วยประเมินภาวะเครียดและคุณภาพการนอนหลับ นอกจากนี้การให้คำปรึกษาทางไกลผ่านระบบบริการสุขภาพทางไกล (Telehealth) ที่ช่วยให้บริการเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุได้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง ทั้งนี้ควรเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและปลอดภัย (Choi et al., 2014)

4. การสนับสนุนการปรับตัว โดยช่วยฝึกทักษะการแก้ปัญหา การตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ ที่สำเร็จได้จริง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมเพื่อเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง (Jin et al., 2023)

5. การทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ พยาบาลจิตเวชจะประสานงานกับแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และนักโภชนาการ เพื่อดูแลภาวะโรคเรื้อรังอย่างครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมให้คำแนะนำที่เกี่ยวกับการสนับสนุนด้านจิตใจอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ (Reist et al., 2022)

6. การพิทักษ์สิทธิ พยาบาลจิตเวชสนับสนุนสิทธิผู้สูงอายุในการตัดสินใจรักษานับข้อมูลครบถ้วน คุ้มครองความเป็นอยู่ที่เหมาะสม และประสานงานเพื่อเข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการที่จำเป็น (Wills, 2022) บทบาทนี้จะช่วยเสริมความมั่นคงทางจิตใจ เพิ่มความรู้สึกมีคุณค่า และลดความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง

นอกจากนี้ พยาบาลจิตเวชควรตระหนักถึงความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใช้เทคโนโลยีออนไลน์ และส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านดิจิทัล (digital literacy) ให้กับผู้สูงอายุและครอบครัวควบคู่กันเพื่อให้การดูแลมีประสิทธิภาพในยุคสังคมดิจิทัล

แนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง

การส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังควรคำนึงถึงปัจจัยร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยการส่งเสริมสุขภาพจิตที่เหมาะสมจะช่วยสร้างทัศนคติบวกและเพิ่มศักยภาพในการดูแลตนเอง แนวทางสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพจิตประกอบด้วย

1. การสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเรื้อรังและการดูแลตนเอง โดยนำเทคโนโลยีสุขภาพ เช่น แอปพลิเคชันจัดการโรคเรื้อรัง หรือวิดีโอสั้นให้ความรู้มาใช้ในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้ ช่วยเพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองและลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคได้ (Wu et al., 2022)

2. การส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมพลังใจและสุขภาวะทางสังคม การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสนับสนุน ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น กลุ่มย่อย กิจกรรมออกกำลังกาย หรือการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น Zoom หรือ LINE เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยลดความโดดเดี่ยว เสริมความภาคภูมิใจ และเพิ่มความสัมพันธ์ทางสังคม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างความหมายในชีวิตมีส่วนช่วยลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญ (Shapira et al., 2021; Maruta et al., 2023)

3. การบำบัดด้วยเทคนิคที่ทันสมัยและเหมาะสมรายบุคคล การใช้ CBT ร่วมกับเทคโนโลยี เช่น การให้คำปรึกษาผ่านวิดีโอ (tele-counseling) หรือแอปพลิเคชัน CBT ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการที่สะดวกและต่อเนื่อง โดยประเมินความเหมาะสมกับทักษะการใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคลอย่างรอบคอบ (Freytag et al., 2022)

การป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง

ภาวะซึมเศร้ากระทบต่อคุณภาพชีวิตและการดูแล